ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ С ПОЛИНОЙ · 17 ОКТЯБРЯ 2026

Клинический компас

Общий план опроса, работы врача и видеоконсультации

Рабочая концепция проекта Даны и Полины. Основа: присланные русскоязычные формы, пять изображений со схемами и проверенные публикации.

Основное решение. PHQ-4 используется в начале как PHQ-2 + GAD-2. При необходимости пациент заполняет PHQ-9 и/или GAD-7. Психиатр интерпретирует результаты и решает, нужны ли врачебные MADRS или HDRS-17. Проверка безопасности проходит отдельно.

Слой	Что входит	Кто отвечает
Безопасность	C-SSRS выбранной версии и маршрут помощи	Клиническая команда
Самоотчет	PHQ-4, PHQ-9, GAD-7	Пациент; программа считает баллы
Клиническая оценка	Беседа, анамнез, MADRS / HDRS-17	Подготовленный специалист
Контекст	Текст, голос, пропуски, «хочу обсудить»	Пациент; врач уточняет

Что Полина найдет в документе

Стр. 2-4: маршрут, пороги и безопасность. Стр. 5-8: интерфейс пациента, работа врача, видеозвонок и анамнез. Стр. 9-10: план реализации и научные ограничения. Стр. 11-13: полные русские формы PHQ-4, PHQ-9 и GAD-7. Стр. 14-15: исходные схемы. Стр. 16-17: ссылки.

Это спецификация для прототипа и обсуждения с психиатром. Валидация отдельных шкал не означает, что весь предложенный цифровой маршрут уже прошел клиническую проверку.

Источники: [1], [3], [4].

Как проходит пациент

Система предлагает следующий шаг по заранее заданным правилам. Врач может менять состав обследования. Срочность помощи не определяется суммой PHQ-4.



Два режима входа. Для первичного скрининга подходит короткий этап PHQ-4. При уже известном расстройстве или назначении врача можно сразу открыть PHQ-9/GAD-7 либо врачебную шкалу, сохранив проверку безопасности.

Обновление первой присланной схемы: вместо одного PHQ-2 вводим PHQ-4 и добавляем отдельный блок безопасности. Общая логика «предложение системы → решение врача → исходные ответы в отчете» сохраняется.

Источники: [1], [2], [5], [11].

Что именно считает программа

Инструмент	Диапазон и правило	Как использовать
PHQ-2	0-6; в приложенной PHQ-4 это пункты 3 + 4	При ≥3 предложить PHQ-9. Это положительный скрининг, а не диагноз.
GAD-2	0-6; в приложенной PHQ-4 это пункты 1 + 2	При ≥3 предложить GAD-7. Решение о ГТР принимает врач.
PHQ-9	0-27; сумма 9 ответов	0-4 минимальные; 5-9 легкие; 10-14 умеренные; 15-19 умеренно тяжелые; 20-27 тяжелые симптомы. ≥10 требует клинической оценки.
GAD-7	0-21; сумма 7 ответов	0-4 минимальные; 5-9 легкие; 10-14 умеренные; 15-21 тяжелые симптомы. ≥10 - повод для клинической оценки.
PHQ-4 целиком	Арифметическая сумма 0-12	В первой версии показывать две подшкалы. Общий показатель использовать только по выбранной методике; он не задает срочность помощи.

Правила развилки

PHQ-2	GAD-2	Предложение системы
<3	<3	Краткая сводка; полные шкалы доступны по клинической необходимости.
≥3	<3	PHQ-9.
<3	≥3	GAD-7.
≥3	≥3	Обе полные шкалы; допускается пауза между ними.

Пример. GAD-2 = 2, PHQ-2 = 3: предложить PHQ-9. Общая сумма PHQ-4 = 5 не заменяет эти два результата. Низкие баллы не исключают расстройства или потребности в помощи.

Как не повторять вопросы. В одной сессии при идентичном тексте, вариантах ответа и периоде можно перенести PHQ-4 (3, 4) → PHQ-9 (1, 2), PHQ-4 (1, 2) → GAD-7 (1, 2). Останутся 7 и 5 новых пунктов. Перенос показать пациенту с возможностью проверки. При другой версии, новом визите или изменении периода назначается полная форма. Такой цифровой переход нужно отдельно проверить в пилоте.

Источники: [1], [2], [3], [4], [14], [15].

Безопасность в начале и дальше

Скрининг безопасности проходит до длинных анкет. C-SSRS не складывается с PHQ-4, PHQ-9 или GAD-7 в единый балл. Ни один такой результат не является гарантией отсутствия опасности.

Сначала вопросы 1 и 2

Проверка мыслей за последний месяц. Это содержание блоков, а не новый перевод шкалы.

На вопрос 2: «нет»

Переход к вопросу 6. Положительный ответ на вопрос 1 сохраняет клиническое значение.

На вопрос 2: «да»

Вопросы 3, 4 и 5, затем вопрос 6. Специалист уточняет актуальность состояния.

Вопрос 6 задается всем

Суицидальное поведение за жизнь; при наличии уточняется период последних трех месяцев.

Что встроить в клинический сценарий

Ситуация	Действие в продукте
Есть сведения об актуальном намерении, плане, недавнем поведении или иной непосредственной опасности	Показать срочный маршрут и подключение специалиста по протоколу; длинные тесты не должны задерживать помощь. При непосредственной опасности направить к местной экстренной службе.
Положительные ответы без установленной непосредственной опасности	Сохранить ответы и время; организовать клиническое уточнение. Любое «да» не означает автоматическую госпитализацию.
Пропуск, отказ или прерывание блока	Статус «безопасность не оценена полностью», возможность связи со специалистом. Не присваивать отрицательный результат.
PHQ-9, пункт 9 >0, либо новые сведения позднее	Вернуться к оценке безопасности независимо от прежних ответов и общего балла. Пункт 9 сам по себе не различает все варианты мыслей и самоповреждения.

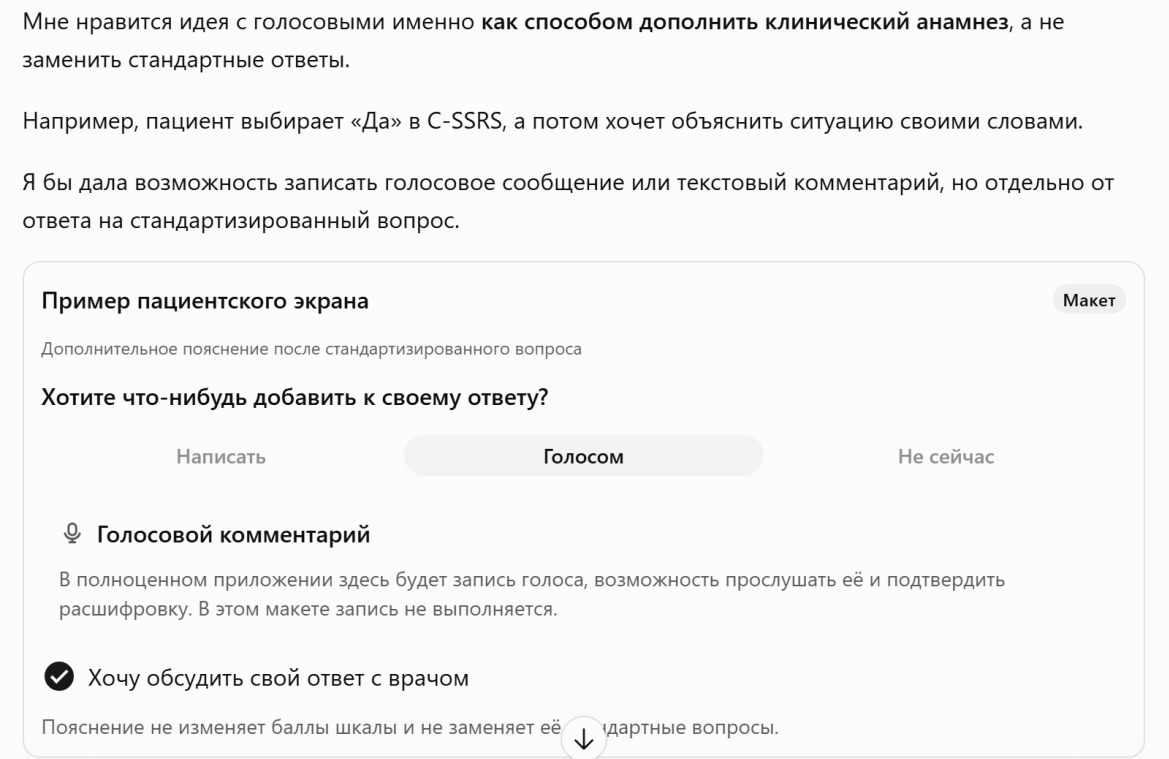
Версия имеет значение. На присланной схеме показана логика краткого интервью. Для самостоятельного заполнения нужна подходящая официальная self-report форма и проверка русской версии; нельзя просто переименовать врачебное интервью в валидированный онлайн-тест.

До работы с реальными пациентами клиника задает ответственного, время реакции, резервный контакт и действия при обрыве связи. Уведомление врачу и экстренный маршрут должны иметь проверяемые статусы. Шкалы не используют как единственный способ предсказать суицид или назначить лечение.

Источники: [5], [6], [7].

Короткий опрос без потери контекста

Показывать по одному пункту, сохранять прогресс и давать ясные действия: ответить, вернуться позже, отметить для беседы. Порядок и формулировки выбранной шкалы сохраняются.



Присланный макет: голос и текст дополняют стандартный ответ. Это иллюстрация интерфейса; сам макет запись не выполняет.

Элемент	Конкретное правило
Стандартный ответ	Только выбранное пациентом значение 0-3 входит в PHQ/GAD. Комментарий и эмоции в голосе не изменяют этот балл.
Текст или голос	Необязательное пояснение; например, лимит записи 60-90 секунд как настройка прототипа. Дать прослушать, удалить и подтвердить расшифровку. Сохранять исходник и отметку о проверке текста.
«Хочу обсудить с врачом»	Отдельный флаг для списка тем к приему. Не влияет на сумму и не означает, что врач уже увидел сообщение.
Пропуск и пауза	Хранить отдельно: не отвечено / отложено / отказ. Пропуск не равен 0. При незавершенной шкале показывать полноту, например 7/9; стандартный итог и категорию не выдавать.

Пояснение «зачем вопрос» размещать отдельно от текста шкалы и проверять, не подсказывает ли оно ответ. Дополнительные разговорные уточнения относятся к анамнезу. При возобновлении в другой день нужно заново подтвердить период оценки; старые и новые временные окна нельзя незаметно объединять.

Сообщения могут читаться не сразу: интерфейс сообщает фактическое время ответа команды. Для срочных ситуаций нужна заметная отдельная кнопка помощи. Нельзя обещать круглосуточный контроль без действующей службы.

Источники: [1], [3], [4], [5].

Что означает «проводит врач»

MADRS и HDRS-17 - шкалы клинической оценки. Специалист беседует с пациентом, уточняет контекст и выставляет оценки по критериям конкретной формы. Пациентские PHQ/GAD можно посчитать автоматически; врачебные баллы требуют решения подготовленного оценщика.

Предлагаемый экран MADRS

Карточки 1-5: темы оценки	Карточки 6-10: темы оценки
1. Видимые проявления печали	6. Нарушения сосредоточения
2. Переживание печали со слов пациента	7. Трудности побуждения к деятельности
3. Внутреннее напряжение	8. Снижение способности переживать чувства
4. Изменения сна	9. Пессимистические мысли
5. Изменения аппетита	10. Суицидальные мысли

Это краткая карта содержания, а не новая русская версия MADRS. В карточки для клинического применения загружаются оригинальные критерии оценок выбранной русской формы, например из приложения Г2 к проверенной редакции рекомендаций.

В каждой карточке: клинические критерии, наблюдения врача, выбранные 0-6 баллов и действие «Подтвердить». Начальное значение пустое. После изменения балла подтверждение снимается.

Правило подсчета

Стандартная итоговая сумма MADRS (0-60) появляется после подтверждения всех 10 пунктов. Пока подтверждено 8/10, можно показать полноту и отдельно промежуточную сумму подтвержденных пунктов с явной подписью «не итог MADRS». Сохранять автора, дату, формат интервью и историю изменений.

HDRS-17: отдельная форма с собственными критериями и диапазонами пунктов; ее нельзя построить как 17 копий карточки MADRS. Не переводить одну шкалу в другую и не требовать обе на каждом визите. Выбор и период повторения задает врач.

Для каждой врачебной формы сохранять ее собственный период оценки по инструкции. Двухнедельное окно PHQ/GAD не переносится в нее автоматически.

Принцип автоматизации: программа хранит, напоминает и суммирует подтвержденные оценки. Диагностическое заключение и выбор терапии оформляет врач. Расшифровка речи может помогать документированию после проверки, но не подставляет клинические баллы.

Источники: [8], [9], [10], [11].

Видеозвонок: обоснование и сценарий

Живое интервью по видеосвязи может быть способом проведения врачебной оценки. Научные данные относятся к оценке специалистом при определенных условиях, а не к распознаванию депрессии программой по лицу или голосу.

Исследование	Проверенный результат	Вывод для проекта
Kobak и соавт., 2008 MADRS [8]	Видео против очного интервью: N=35, ICC=0,94. Отдельная телефонная группа: N=35, ICC=0,93.	Поддерживает возможность дистанционного проведения подготовленным оценщиком; исследование небольшое.
Kobak, 2004 HAMD [9]	В видео/очной группе N=21; ICC=0,88. Сравнивались независимые интервью.	Нужны качество связи и соблюдение процедуры интервью.
Kølbæk и соавт., 2025 HAM-D17 [10]	110 сотрудников; доля оценок в допустимом отклонении от эталона выросла с 43% до 70% после обучения.	Обучение оценщиков - отдельная задача. Это исследование тренинга, а не доказательство ИИ-диагностики.



Да, если интервью дистанционно проводит специалист. И это подтверждено исследованиями.

Kobak et al., 2008 — дистанционная MADRS

В исследовании сравнили оценку депрессии при очном интервью, видеосвязи и телефонном разговоре. Для видеосвязи согласованность результатов была высокой: ICC = 0,94.

Читать исследование ↗ PubMed

Hamilton Depression Rating Scale — дистанционная оценка

В исследовании 2004 года оценка по видеосвязи показала высокую согласованность с очным интервью (ICC = 0,88). PubMed

А исследование 2025 года показало, что даже медицинским специалистам необходима подготовка для достаточно надёжного выставления баллов по HDRS-17. PMC

Поэтому я вижу три уровня автоматизации.

Присланный фрагмент обсуждения. Числа проверены по публикациям выше. ICC описывает согласованность измерений; 0,94 нельзя читать как «94% точности диагноза».

Практический сценарий

До звонка пациент заполняет назначенные анкеты. В начале врач проверяет личность, текущее местонахождение, приватность и план при обрыве связи. Во время беседы уточняет ответы и при необходимости заполняет MADRS/HDRS. После - подтверждает баллы, фиксирует выводы и дальнейший план.

Для первой сборки достаточно записи на прием и перехода в согласованный сервис видеосвязи. Запись разговора не обязательна; для нее нужен отдельный согласованный порядок. При плохой связи, невозможности полноценной оценки или необходимости осмотра врач выбирает другой формат. Российские организационные требования к телемедицине проверяются отдельно от психометрии шкал [13].

Источники: [8], [9], [10], [13].

Анамнез и полезная сводка врачу

После основного опроса добавлять только нужные врачу модули. Это отдельные данные анамнеза: они не меняют PHQ/GAD и не создают новый диагностический балл.

Модуль	Как сделать понятным пациенту
Течение состояния	Когда началось, что изменилось в повседневной жизни, были ли похожие эпизоды и лечение. Клинические уточнения, включая признаки гипомании/мании, выполняет специалист.
Соматическое здоровье	Заболевания, текущие препараты и вещества, сон и физические симптомы. Не приписывать все жалобы депрессии; необходимость обследования решает врач.
Семейный анамнез	Начать с родителей, братьев/сестер и детей, затем расширять дерево. Разрешить «не знаю», «не помню», «не хочу отвечать». Хранить родство, примерный возраст начала, источник и уверенность в сведениях.
Подсказки о родственниках	Если диагноз неизвестен, спросить понятными словами о наблюдавшихся проблемах и лечении; записать рассказ как неподтвержденные сведения. По косвенному описанию родственнику диагноз не присваивать.
Стрессоры и детский опыт	Необязательный блок с правом отложить и обсудить лично. Не делать условием завершения основного скрининга.
Если сохраняется постковидный фокус	Отдельно фиксировать даты инфекции и госпитализации, существовавшие ранее жалобы и текущие симптомы. Пользу именно для этой группы проверять; факт перенесенного COVID не устанавливает причину депрессии.

Учебный пример сводки

Полнота: PHQ-9 9/9, GAD-7 7/7.
Самоотчет: PHQ-9 12/27; GAD-7 8/21. Это выраженность симптомов, диагноз не сформирован.
Безопасность: отдельная датированная запись; новые сведения показаны врачу независимо от сумм.
Темы к беседе: сон, нежелательные эффекты лечения; один голосовой комментарий, расшифровка подтверждена пациентом.
Действие врача: уточнить течение, функционирование и возможные иные причины; выбрать дальнейшее обследование.

В отчете отделять самоотчет, рассказ о родственниках, наблюдения врача и его заключение. Графики строить отдельно по каждой шкале с датой, версией и полнотой. Незавершенная анкета не превращается в нулевую точку; один балл не определяет автоматически улучшение или ремиссию.

Источники: [3], [4], [11].

План первой рабочей версии

Ниже - предлагаемое распределение задач. Сначала нужен сквозной сценарий на учебных данных: от приглашения пациента до сводки врачу. Сроки привязать к требованиям конкурса и доступному коду.

Этап	Дана / клиническая часть	Полина / реализация	Готовый результат
1. Правила	Выбрать версии форм, согласовать тексты, пороги и действия безопасности с психиатром.	Оценить существующий код, условия его использования и данные, которые он хранит.	Короткая спецификация и набор учебных сценариев.
2. Опрос	Проверить PHQ-4 → полные формы, подписи к результатам и отдельные пояснения.	Реализовать ответы, паузу, сохранение, пропуски и флаг обсуждения; расчет без ИИ.	Работающий опрос и прозрачная сводка.
3. Кабинет	Определить состав отчета и сценарий MADRS с подтверждением пунктов.	Показать исходные ответы, комментарии, версии; добавить подтверждение врачебных оценок и экспорт.	Один полный пример работы врача.
4. Связь	Провести экспертный разбор сценариев; проверить понятность с пользователями.	Добавить запись/переход к видеоприему; проверить состояния уведомлений и ошибки.	Демонстрация и перечень результатов проверки.

Критерии приемки, которые нельзя пропустить

Проверка	Ожидаемое поведение
PHQ-2 / GAD-2 = 2 и = 3	Порог срабатывает только при ≥3 соответствующей подшкалы.
Хотя бы один ответ отсутствует	Нет стандартного итога неполной шкалы; данные не заполняются нулями.
Пункт 9 PHQ-9 положительный	Отдельный сигнал для клинического уточнения при любом общем балле.
C-SSRS: вопрос 2 «нет»	Вопрос 6 все равно предусмотрен; проверены оба перехода.
MADRS 9/10 подтверждений	Нет финального итога; изменение подтвержденного пункта требует нового подтверждения.
Связь оборвалась / врач недоступен	Понятный следующий шаг, сохранение данных, отсутствие ложного обещания помощи.

Начальная версия может обойтись без анализа видео, автоматической диагностики, генерации лечебных назначений и сложной игровой механики. Отличие проекта проверять по завершению опросов, удобству пациента, времени врача и качеству собранного контекста. Эти преимущества пока являются гипотезами.

Что подтверждено, что еще проверить

Основание	Что известно	Практическая граница
Русский PHQ-4, 2024 [1]	2000 взрослых 18-60 лет; подтверждены психометрические свойства и две подшкалы.	Это обоснование шкалы в общей популяции, а не доказательство точности нашего приложения или постковидного маршрута.
Русский PHQ-9, 2023 [3]	1800 взрослых; внутренняя согласованность α=0,89 и факторная валидность.	В статье обозначена необходимость дальнейших испытаний с клинически диагностированными пациентами.
Русский GAD-7, 2023 [4]	1130 взрослых; α=0,93 и данные о валидности в общей популяции.	Авторы также указывают на необходимость дальнейшей клинической проверки диагностических характеристик.

Как корректно говорить о Минздраве

В проверенной редакции рекомендаций по депрессивному эпизоду и рекуррентному депрессивному расстройству 2024 года указаны HDRS (приложение Г1) и MADRS (Г2). В рекомендациях по ГТР 2024 года есть GAD-7 (Г2). Это не означает одобрение всего приложения, автоматической диагностики или любой измененной русской формы [11, 12].

Текст GAD-7 в приложении к рекомендациям отличается от присланного перевода из статьи. Для проекта нельзя молча смешивать пункты разных переводов. В этом PDF воспроизведены именно формы, присланные Даной; при внедрении нужно явно выбрать и закрепить одну версию.

Что зафиксировать до клинического внедрения

Возрастная область первой версии - взрослые 18+. Нужны клинический владелец сценария, проверка цифровых переходов и понятности интерфейса, безопасная работа с медицинскими данными и действующий маршрут реагирования. Для видеоприема учитывать применимый порядок телемедицины, включая приказ Минздрава №193н от 11.04.2025; измерительная сопоставимость шкал сама по себе не разрешает любой вид дистанционного приема [13].

Источники и права. Статьи PHQ-9/GAD-7 на PsyJournals имеют обозначение CC BY-NC 4.0. Условия оригинальных PHQ/GAD и конкретных русских переводов следует различать. Перед коммерческим использованием закрепить права на нужную форму и условия исходного кода; общедоступная статья не является разрешением на любую коммерческую переработку.

C-SSRS и врачебные формы здесь объяснены и связаны с источниками. Полностью переписаны только три присланных русских опросника на следующих страницах; это не полный комплект всех диагностических методик.

Источники: [1], [3], [4], [6], [11], [12], [13].

PHQ-4: русскоязычная форма

PHQ-4 = GAD-2 + PHQ-2. Порядок ниже соответствует приложению к российской адаптации 2024 года и присланному тексту.

Инструкция. Оцените, пожалуйста, насколько часто следующие проблемы беспокоили вас в течение прошедших двух недель. Для ответов используйте следующую шкалу:

0	1	2	3
Совсем нет	В течение нескольких дней	Более, чем половину этого времени	Почти каждый день

Проблема	0	1	2	3
1. Чувство тревоги или раздражения	0	1	2	3
2. Неспособность справиться со своим беспокойством	0	1	2	3
3. Снижение интереса и удовольствия от привычных дел	0	1	2	3
4. Чувство подавленности или безнадежности	0	1	2	3

Ключ и использование в проекте

GAD-2: пункты 1 + 2, диапазон 0-6.
PHQ-2: пункты 3 + 4, диапазон 0-6.
В ключе публикации порог ≥3 применяется к каждой подшкале отдельно. В интерфейсе это основание предложить уточнение, а не установить диагноз.

> **Не добавлять после длинных шкал как еще один обязательный тест.** Эти четыре пункта уже представлены в PHQ-9 и GAD-7. PHQ-4 нужен как короткий вход, когда такой вход полезен пациенту и врачу.

Сумма двух подшкал арифметически дает 0-12. Для первой версии достаточно показывать PHQ-2 и GAD-2 отдельно. Нельзя складывать их с C-SSRS или называть суммарный результат общим показателем «психического здоровья».

При пропуске одного из двух пунктов соответствующая подшкала не завершена. Если другая подшкала заполнена полностью, ее можно отобразить отдельно с указанием полноты всего PHQ-4.

Источник формы: Золотарева А.А., Костенко В.Ю., Лебедева А.А., Чумакова М.А., 2024, приложение, с. 54. Текст предоставлен Даной; сверено с публикацией.

Источники: [1], [2].

PHQ-9: русскоязычная форма

Опросник здоровья пациента. Перевод из присланного приложения к статье А.А. Золотаревой, 2023.

Инструкция. Оцените, пожалуйста, насколько часто следующие проблемы беспокоили вас в течение прошедших двух недель. Для ответов используйте следующую шкалу:

0	1	2	3
Совсем нет	В течение нескольких дней	Более, чем половину этого времени	Почти каждый день

Проблема	0	1	2	3
1. Снижение интереса и удовольствия от привычных дел	0	1	2	3
2. Чувство подавленности или безнадежности	0	1	2	3
3. Проблемы со сном (неспособность заснуть, раннее пробуждение или слишком долгий сон)	0	1	2	3
4. Чувство усталости или недостатка энергии	0	1	2	3
5. Плохой аппетит или переедание	0	1	2	3
6. Плохое мнение о себе или чувство, что не смог оправдать ожиданий моей семьи	0	1	2	3
7. Проблемы с концентрацией внимания (например, при чтении газеты или просмотре телевизионной передачи)	0	1	2	3
8. Замедленность движений или речи, которая стала заметна другим людям, или, напротив, суетливость, когда движения и речь стали более быстрыми и беспокойными	0	1	2	3
9. Мысли о том, что мне бы хотелось умереть или причинить себе боль	0	1	2	3

Обработка. Сложить все девять оценок: 0-27. Порог ≥10 используется для выявления вероятного клинически значимого состояния и требует оценки специалистом; сам по себе диагноз не устанавливает. Диапазоны выраженности приведены на стр. 3.

Безопасность. Любой ответ >0 на пункт 9 требует отдельного клинического уточнения независимо от суммы. Пропуск не равен 0; стандартный итог неполной формы в нашем прототипе не формируется.

Текст пунктов предоставлен Даной и сохранен без смысловой переработки; изменена только верстка. Источник: приложение к статье, DOI 10.17759/cpse.2023120406.

Источники: [3], [14].

GAD-7: русскоязычная форма

Шкала генерализованного тревожного расстройства. Перевод из присланной статьи А.А. Золотаревой, 2023.

Инструкция. Оцените, пожалуйста, насколько часто следующие проблемы беспокоили вас в течение прошедших двух недель. Для ответов используйте следующую шкалу:

0	1	2	3
Совсем нет	В течение нескольких дней	Более, чем половину этого времени	Почти каждый день

Проблема	0	1	2	3
1. Чувство тревоги или раздражения.	0	1	2	3
2. Неспособность справиться со своим беспокойством.	0	1	2	3
3. Чрезмерное беспокойство по разным поводам.	0	1	2	3
4. Неспособность расслабляться.	0	1	2	3
5. Ощущение такого беспокойства, что трудно найти себе место.	0	1	2	3
6. Склонность быстро испытывать злость или раздражительность.	0	1	2	3
7. Чувство страха, как будто может случиться что-то ужасное.	0	1	2	3

Ключ и использование в проекте

Сложить все семь оценок: 0-21. Диапазоны выраженности тревожных симптомов: 0-4 минимальные, 5-9 легкие, 10-14 умеренные, 15-21 тяжелые. Порог ≥10 - основание для дальнейшей клинической оценки, а не автоматический диагноз ГТР.

> GAD-7 спрашивает о последних двух неделях, но диагноз ГТР требует оценки более широкого клинического контекста и течения состояния. Высокий балл не доказывает, что тревога вызвана именно ГТР.

При пропусках стандартный итог в нашем прототипе не формируется. При переносе первых двух ответов из PHQ-4 нужно совпадение версии, формулировок, периода и вариантов ответа.

Текст предоставлен Даной; сверено с приложением к публикации, DOI 10.17759/cpp.2023310402. Использован обычный дефис в «что-то»; смысл и остальные формулировки сохранены. Это именно присланный перевод, а не дословный текст другой формы из клинических рекомендаций.

Источники: [4], [12], [15].

Приложенные схемы маршрута

Два исходных изображения Даны. Читаем их вместе: первая схема задает роли, вторая добавляет безопасность и короткий комбинированный скрининг.



Схема 1. Сохранить предложение системы, решение врача, стандартные ответы и исходные комментарии в сводке. Один PHQ-2 заменить на PHQ-4 при первичном скрининге.

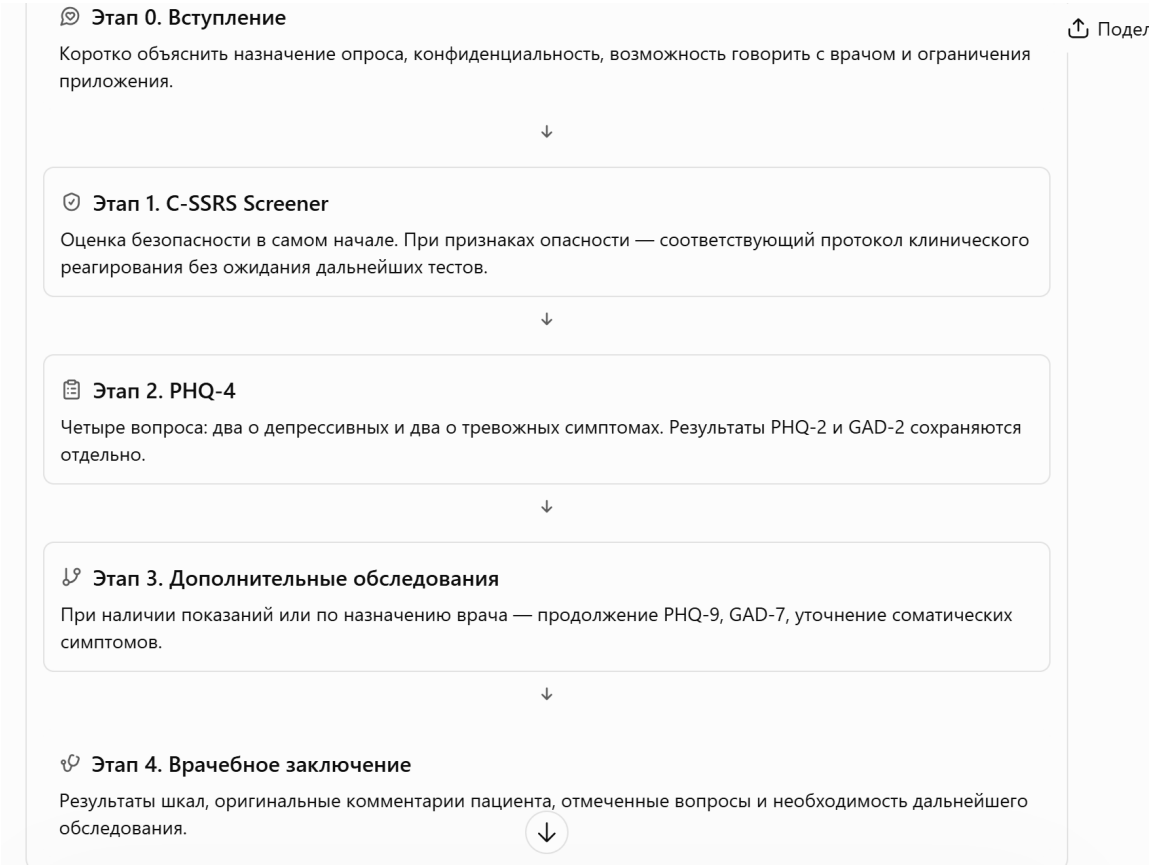


Схема 2. Порядок в целом подходит для прототипа. Перед внедрением выбрать точную форму C-SSRS, определить реакции команды и проверять безопасность повторно при новых сведениях.

Приложенная развилка C-SSRS

Там показана правильная идея условных переходов:



Именно такая последовательность приведена в официальном кратком протоколе Columbia ↗.

The Columbia Li...

Но я бы **не копировала из картинки готовые категории риска без клинической проверки**. Особенно важно не забыть шестой вопрос: даже при отрицательных ответах на вопросы о текущих мыслях история суицидального поведения может иметь большое клиническое значение.

Кроме того, в краткой C-SSRS не складывают ответы в единый числовой показатель по принципу PHQ-9. И положительный результат не означает автома[illegible]ески необходимость госпитализации — срочность действий определяется состоянием, конкретными ответами и оценкой специалиста.

Изображение Даны. Последовательность вопросов сверена с официальным кратким протоколом Columbia; это иллюстрация маршрута, а не источник самостоятельной диагностики.

Сохранить: вопросы 1 и 2 в начале; при отрицательном ответе на 2 - переход к 6; при положительном - уточнение 3-5, затем 6; вопрос 6 нужен всем.

Уточнить: конкретную версию, период оценки, формат самостоятельного заполнения или интервью и действия команды. Отрицательные ответы не дают программе права написать «риска нет». Решения о срочности и помощи принимаются с клиническим учетом ситуации.

Остальные два присланных изображения включены на стр. 5 (голосовые комментарии) и стр. 7 (видеопроведение шкал). Все пять изображений использованы как материалы обсуждения; научные выводы опираются на отдельные источники ниже.

Источники: [5], [6], [7].

Источники и русские формы

Ссылки проверены при подготовке 17.10.2026. Номера в тексте ведут к соответствующим записям; внешние ссылки кликабельны.

[1] Золотарева А.А., Костенко В.Ю., Лебедева А.А., Чумакова М.А. (2024). Скрининг тревоги и депрессии в общей популяции: адаптация Patient Health Questionnaire-4 в России. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева, 58(2), 45-54.
Открыть источник
Полный текст и русская форма на последней странице. DOI в метаданных: 10.31363/2313-7053-2024-899.

[2] Kroenke K., Spitzer R.L., Williams J.B.W., Löwe B. (2009). An ultra-brief screening scale for anxiety and depression: the PHQ-4. Psychosomatics, 50(6), 613-621.
Открыть источник
Первичная публикация о комбинации двух коротких подшкал. DOI: 10.1176/appi.psy.50.6.613.

[3] Золотарева А.А. (2023). Диагностика депрессии: психометрическая оценка русскоязычной версии опросника здоровья пациента (Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9). Клиническая и специальная психология, 12(4), 107-121.
Открыть источник
Русская форма в приложении. DOI: 10.17759/cpse.2023120406. Выпуск датирован 2023 годом, на сайте указана публикация 13.02.2024.

[4] Золотарева А.А. (2023). Адаптация русскоязычной версии шкалы генерализованного тревожного расстройства (Generalized Anxiety Disorder-7). Консультативная психология и психотерапия, 31(4), 31-46.
Открыть источник
Русская форма в приложении. DOI: 10.17759/cpp.2023310402.

[5] The Columbia Lighthouse Project. C-SSRS Screen with Triage Points for Outpatient/Ambulatory (форма 2026).
Открыть источник
Официальный англоязычный протокол: порядок 1-2, условные 3-5, обязательный вопрос 6 и временные окна.

[6] The Columbia Lighthouse Project. Translations.
Открыть источник
Официальная страница переводов и доступа к русским формам. Для проекта выбрать точную версию и ее назначение; собственный перевод здесь не предлагается.

[7] NICE. Self-harm: assessment, management and preventing recurrence (NG225), раздел 1.6.
Открыть источник
Официальные рекомендации: ограничения шкал для предсказания суицида и принятия решений о помощи. Это международное руководство, а не российская регуляторная норма.

[8] Kobak K.A., Williams J.B.W., Jeglic E., Salvucci D., Sharp I.R. (2008). Face-to-face versus remote administration of the Montgomery-Asberg Depression Rating Scale using videoconference and telephone. Depression and Anxiety, 25(11), 913-919.
Открыть источник
Первичное исследование MADRS: видео и телефон. DOI: 10.1002/da.20392. PubMed PMID: 17941100.

Источники: продолжение

[9] Kobak K.A. (2004). A comparison of face-to-face and videoconference administration of the Hamilton Depression Rating Scale. Journal of Telemedicine and Telecare, 10(4), 231-235.
Открыть источник
Первичное исследование: сопоставление видео и очного интервью, ICC=0,88. DOI: 10.1258/1357633041424368.

[10] Kølbæk P. и соавт. (2025). Improving the Accuracy and Reliability of Ratings on the Hamilton Depression Rating Scale via a Video-Based Training Program. Acta Psychiatrica Scandinavica, 152(6), 462-472.
Открыть источник
Подготовка оценщиков: 110 сотрудников, 43% → 70% в допустимом отклонении от эталона. DOI: 10.1111/acps.70029.

[11] Клинические рекомендации «Депрессивный эпизод, Рекуррентное депрессивное расстройство», редакция 2024, ID 301, версия 301_3; раздел 2.1 и приложения Г1/Г2.
Открыть источник
Официальная карточка. Текст проверен по доступной копии редакции от 26.08.2024: Открыть доступную копию. Перед внедрением перепроверить актуальную редакцию в Рубрикаторе.

[12] Клинические рекомендации «Генерализованное тревожное расстройство», редакция 2024, ID 457, версия 457_3, приложение Г2.
Открыть источник
Официальная карточка. Доступный текст приложения: Открыть доступную копию. Формулировки отличаются от присланного перевода GAD-7.

[13] Приказ Минздрава России от 11.04.2025 №193н «Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий».
Открыть источник
Копия зарегистрированного нормативного документа. Организацию реального видеоприема согласует медицинская организация с учетом действующих норм и конкретного вида помощи.

[14] Kroenke K., Spitzer R.L., Williams J.B.W. (2001). The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. Journal of General Internal Medicine, 16(9), 606-613.
Открыть источник
Первичная публикация PHQ-9; правила и клиническая интерпретация показателей.

[15] Spitzer R.L., Kroenke K., Williams J.B.W., Löwe B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of Internal Medicine, 166(10), 1092-1097.
Открыть источник
Первичная публикация GAD-7. DOI: 10.1001/archinte.166.10.1092.

Происхождение приложений

Включены все пять изображений Даны: 115621 и 124133 - схемы маршрута (стр. 14); 124210 - макет голосового комментария (стр. 5); 124226 - развилка C-SSRS (стр. 15); 124603 - фрагмент обсуждения видеосвязи (стр. 7). Изображения являются материалами проекта, а не независимыми исследованиями.

Русские формулировки PHQ-4, PHQ-9 и GAD-7 предоставлены в сообщении Даны и сверены с указанными публикациями. Ключи в описании проекта интерпретированы как правила скрининга. Авторские предложения по интерфейсу, распределению задач и пилоту специально отделены от подтвержденных свойств шкал.